想定Q&A集 法人経営戦略

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

想定Q&A集 ー 法人経営環境と大橋病院経営戦略

作成日: 令和8年4月11日
想定読者: 病院運営戦略会議・経営会議の説明者
想定質問者: 理事長、事務部長、診療科長、看護部長

I. 法人財務に関する質問

Q1. 令和7年度はなぜ10.7億円の赤字予算なのか。法人の経営は大丈夫か。

【結論】
赤字の主因は大森地区再開発事業と100周年関連の一時的要因であり、法人の存続を脅かすものではない。ただし、教育活動収支（本業）が△12.9億円と大幅赤字である点は注視が必要。

【根拠データ】
・基本金組入前当年度収支差額: △10.7億円（事業活動収支予算書）
・R6予算では+2.1億円の黒字であり、R7は△12.8億円の急激な悪化
・設備投資113.6億円（うち大森再開発78.2億円）が資金需要の大半
・特別収支に施設売却差額+6.0億円を計上し赤字幅を圧縮済み

【補足/対策】
中期計画ではR8に+3.5億円、R9に+7.7億円の黒字転換を想定している。手許資金は168.5億円（R7末見込み）を保有しており、短期的な資金繰りに問題はない。ただし3年間で155億円の現預金取崩計画があり、R9末の手許資金は約88億円に減少する見込み。コロナ補助金の全廃と物価高騰が続く中、医療収入の着実な増加が回復の前提条件。

Q2. 中期経営計画（R7-R9）で3年間の黒字がわずか0.48億円というのは、計画として妥当なのか。

【結論】
大森再開発という100年に一度の大型投資の最中であり、損益分岐点ギリギリの計画はやむを得ない面がある。ただし、計画の前提（医療収入年率+1.7%成長）の実現性には注意が必要。

【根拠データ】
・3年合計: 第1次収入3,054億円 − 第1次支出2,877億円 = 粗利益177億円（法人全体収支計画）
・前回中期実績比: 粗利益△15.4%（△32億円）の減少
・医療収入: R7 776億円→R8 789億円→R9 804億円（年率+1.7〜1.9%の成長前提）
・R7上期実績: 医療収入は予算比△0.4%と未達

【補足/対策】
前回中期（R4-R6）では計画比+27億円の上振れ実績があり、保守的な計画を上回る実績を出す組織文化がある。R8診療報酬改定で3病院合計+3億円以上の増収効果が見込まれており、これが計画に織り込まれていれば実現可能性は高まる。計画外の収益改善余地（算定漏れ防止、ダヴィンチ拡大等）も存在する。

Q3. 法人収入の77.6%が医療収入だが、この依存度は高すぎないか。

【結論】
医療系私立大学としては標準的な構成比である。問題は依存度の高さそのものではなく、医療経費の伸び（+5.3%）が医療収入の伸び（+2.0%）を上回る「逆ザヤ」構造にある。

【根拠データ】
・医療収入: 775.6億円（構成比77.6%）（事業活動収支予算書）
・学納金: 130.6億円（13.1%）
・補助金: 52.6億円（5.3%）
・医療経費: 310.7億円（医療収入比40.1%）、前年比+15.6億円（+5.3%）
・医療収入増: +15.0億円（+2.0%）→ 純増寄与はわずか△0.6億円

【補足/対策】
収入多角化として、生命理工学部構想（R10設置予定、補助金約20億円確定）や産学連携の推進が計画されているが、短期的には3病院の経営改善が最も確実かつインパクトの大きい収益源である。

II. 大橋病院の経営に関する質問

Q4. 大橋病院は3病院中で最も小さいが、法人にどれだけ貢献しているのか。

【結論】
規模では最小だが、収益効率では最高水準。3病院中で唯一の粗利益改善（+122.4%）を達成しており、法人の収支改善に最も貢献している。

【根拠データ】
・入院単価: 102,345円（3病院最高、大森92,835円、佐倉85,360円）（上期事業運営状況）
・平均在院日数: 8.8日（3病院最短）
・粗利益前年比: 大橋+122.4% vs 大森△32.9% vs 佐倉△26.4%（月次分析レポート）
・救急謝絶率: 19.0%（3病院最良、大森26.6%、佐倉31.3%）

【補足/対策】
大橋の「短在院日数・高入院単価・高稼働率」モデルは、同クラスの急性期1算定病院（n=270）の中でも上位に位置する。同クラス平均の病床稼働率77.5%に対し88.9%（+11.4pt）、入院単価71,439円に対し100,719円（141%）と、限られた320床で高い収益を上げている。

Q5. 外来患者数が累計△8.5%と減っているが、経営に問題はないのか。

【結論】
外来単価+11.6%で総額は維持しているが、量の減少を単価だけで補い続けるのは限界がある。構造的な対策が必要。

【根拠データ】
・1日平均外来患者数: 852人（予算910人、△58人）（月次分析レポート）
・外来単価: 22,841円（前年21,551円、+6.0%）
・外来収入累計: 51.3億円（前年比+2.4%でかろうじて増収）
・初診率: 7.6%（目標10%未達）（上期事業運営状況）
・整形外科紹介: △543件（全科最大の減少）

【補足/対策】

外来患者数減少の要因は複合的:
①逆紹介の推進（地域医療支援病院の機能強化として適切な面も）、②整形外科の紹介激減（構造的問題）、③高齢化に伴う受診控え。対策としてWeb予約システム導入、広報強化（HP閲覧+5万件）、紹介元への訪問活動が進行中。外来患者数を予算水準に戻すと年間+3.2億円の増収が見込まれる。

Q6. 大森再開発に投資が集中しているが、大橋病院の設備投資は大丈夫か。

【結論】
中期計画期間（R7-R9）の大橋への設備投資は限定的にならざるを得ない。既存設備の最大活用と、投資対効果の高い案件への集中が必要。

【根拠データ】
・3年間の設備投資: 306.8億円（法人全体収支計画）
・大森再開発: 194.0億円（63.2%）
・習志野新棟: 12.4億円（4.0%）
・残り（3病院+全学の通常設備投資）: 100.4億円（年間約33億円）

【補足/対策】
大橋病院の既存設備は比較的良好な状態にあり、ダヴィンチは稼働中、ICU/HCU/SCUも運用可能。今後の重点投資候補はDX関連（胸部X線AI、コミュニケーションアプリ）で、比較的少額で大きな業務改善効果が期待できる。大型の設備更新が必要な場合はR10以降（大森再開発完了後）の次期中計で対応する方針が現実的。

Q7. 令和8年度の診療報酬改定で大橋病院にどのような影響があるか。

【結論】
DPC係数改定等による増収効果が見込まれる。施設基準の維持と算定漏れ防止が効果最大化の鍵。

【根拠データ】
・急性期充実体制加算: 全身麻酔3,261件で基準2,000件を大幅超過。維持は確実
・地域医療支援病院: 紹介率87.1%（要件65%以上をクリア）
・外来化学療法加算: 高水準の稼働を維持（資料2でモニタリング済み）

【補足/対策】
改定効果を最大化するためには、①施設基準の総点検と早期届出、②算定漏れの防止（施設基準管理システムの導入）、③DPC期間II以内退院率の改善が重要。R8 Q1の施設基準届出を確実に行い、早期に効果を取り込む。

III. 3病院比較・ベンチマークに関する質問

Q8. 大橋病院の外来単価（22,000円）が佐倉（27,800円）より低いのはなぜか。

【結論】
佐倉病院の外来単価が高い主因は、外来患者の疾患構成と診療科ポートフォリオの違いである。大橋は外来患者数が少ないにもかかわらず単価も低い点は改善余地がある。

【根拠データ】
・大橋外来単価: 22,000円、佐倉外来単価: 27,800円、大森外来単価: 23,463円（上期事業運営状況）

・大橋病院の化学療法3科（外科・泌尿器科・消化器内科）は+3,924万円/月の増収に寄与
・一方、整形外科等の低単価外来の構成比が影響している可能性

【補足/対策】
外来単価の改善策としては、①外来化学療法のさらなる拡大（高額薬剤使用症例の増加）、②高額医療機器（PET-CT、MRI）の稼働率向上、③初診率の改善（紹介患者は一般外来より単価が高い傾向）が有効。佐倉の高単価要因を詳細分析し、大橋に適用可能な要素を特定することも検討すべき。

Q9. 救急謝絶率が19%と良い数字だが、さらに下げる必要はあるのか。

【結論】
目標30%未満に対し19%は優秀な実績。さらなる引き下げよりも、入院率の向上（45.7%、前年比+7.9pt）を通じた救急からの入院収入最大化に注力すべき。

【根拠データ】
・大橋病院謝絶率: 19.0%（目標30%未満、3病院最良）（上期事業運営状況）
・入院率: 45.7%（前年比+7.9pt増）
・救急搬送入院患者: 月平均111.2名（前年比+4.2名）
・大森病院謝絶率: 26.6%（目標25%を上回る）
・佐倉病院謝絶率: 31.3%

【補足/対策】
謝絶率のさらなる低下は、マンパワーの制約から限界がある。それよりも救急からの入院率向上と入院単価の維持が収益に直結する。月平均111.2名の救急入院 × 入院単価102,345円 × 平均在院日数8.8日 = 月約1億円の収入寄与と推計される。

IV. 将来戦略に関する質問

Q10. 大森病院新外来棟（R9.9月竣工）は大橋病院にどう影響するか。

【結論】
大森新外来棟の完成は、区西南部の大橋にとって競合強化ではなく、グループ内での役割分担が明確化する機会。高度急性期特化と地域密着の二兎を追う戦略が重要。

【根拠データ】
・大森新外来棟: 令和9年9月竣工予定（上期事業運営状況）
・大森と大橋の医療圏は異なる（大森: 大田区中心、大橋: 目黒区・世田谷区中心）
・大森の1日平均外来患者: 1,933.8人（大橋の2.3倍）

【補足/対策】
大森の外来機能が強化されることで、紹介・逆紹介のネットワークがより効率化される可能性がある。大橋は区西南部の「地域密着型の高度急性期病院」としてのポジションを明確にし、ダヴィンチ手術や救急医療での差別化を継続すべき。R10以降は大橋の設備更新に投資余力が回復する見込みであり、次期中計に向けた設備計画を早期に検討開始することが望ましい。

Q11. 中期計画期間中に新たな借入をしない方針だが、設備投資が足りなくなった場合はどうするのか。

【結論】
法人は手許資金（168.5億円）からの取崩で設備投資を賄う方針。ただし3年間で155億円の取崩計画であり、追加投資の余地は限られる。

【根拠データ】
・R7翌年度繰越支払資金: 168.5億円（資金収支予算書）
・3年間の現預金取崩: 155.0億円（法人全体収支計画）
・長期借入金返済: 18.2億円/3年
・新規借入: キャッシュフロー計画に計上なし

【補足/対策】
大森の2号館改修は「想定工費を大きく超過したことから、必要最小限の改修にとどめるべく大幅な計画見直し」が行われた（上期事業運営状況）。これは法人が資金管理に慎重であることの表れ。大橋病院の設備投資は、ROIの高い案件（DX関連、算定加算の取得に直結する設備）に集中し、大型投資はR10以降に計画するのが現実的。

Q12. 診療科ポートフォリオの二極化（化学療法3科 vs 手術3科）にどう対応すべきか。

【結論】
短期的には好調な化学療法3科の収益をさらに伸ばしつつ、不調な手術3科（整形外科・脳神経外科・心臓血管外科）の減収要因を個別に分析し対策を打つべき。

【根拠データ】
・化学療法3科（外科・泌尿器科・消化器内科）: +3,924万円/月（月次分析レポート）
・手術3科（整形外科・脳神経外科・心臓血管外科）: △5,672万円/月（月次分析レポート）
・整形外科: 紹介△543件（全科最大の減少）→ 外来+入院合算△2,492万円/月

【補足/対策】
整形外科の紹介減少は全科で最大のインパクトであり、最優先の対策対象。原因として考えられるのは:
①医師の退職・異動、②近隣の競合病院への患者流出、③紹介元医師の高齢化・閉院。病診連携室と連携した紹介元への訪問活動と、整形外科の強みを活かした地域セミナーの開催が有効。一方、化学療法3科は外来化学療法加算の算定状況（資料2でモニタリング済み）を継続強化する。

Q13. 法人が「DXの推進」を基本方針に掲げているが、大橋病院ではどう進めるか。

【結論】
大橋病院のDX推進は「コスト削減・業務効率化」と「収益向上」の両面で取り組む。投資額が小さく効果が大きい施策を優先する。

【根拠データ】
・組織目標（R8）:「医療DX・タスクシフト・タスクシェアを推進」（組織目標 各所属）
・上期進捗: 胸部X線診断AIとコミュニケーションアプリ（Join等）の導入準備中（上期事業運営状況）
・法人レベル: 電子処方箋・救急時医療情報閲覧機能の導入完了、電子カルテ情報共有サービスの検討中

【補足/対策】
優先すべきDX施策:
施設基準管理システム導入（大森が9月導入済み → 大橋への展開）: 算定漏れ防止に直結
AI電話応答システム（大森で導入済み）: 紹介患者の受入効率化
電子カルテ情報共有サービス: 地域連携の強化に寄与
胸部X線AI: 診断精度向上と読影負荷の軽減

Q14. 100周年記念寄付金の進捗（62%達成）が大橋病院に与える影響は。

【結論】
寄付金の目標達成・未達は直接的には法人全体の財務に影響するが、大橋病院への間接的影響は限定的。

【根拠データ】
・寄付金実績: 8月末18億5,370万円（目標30億円、達成率62%）（上期事業運営状況）
・前回90周年実績17億8,140万円は超過
・令和7年度寄付金予算: 10.9億円（R6比△1.4億円）

【補足/対策】
寄付金は主に大森再開発の財源に充当される。目標未達の場合、手許資金の取崩額が拡大するか、再開発の一部計画見直しが生じる可能性がある。大橋病院としては、寄付金の動向に左右されない自律的な収益構造の確立が重要。

Q15. 生命理工学部（R10設置予定）は大橋病院にメリットがあるか。

【結論】
直接的なメリットは限定的だが、法人全体の収入多角化と研究力強化に寄与し、中長期的には大橋病院の臨床研究や治験への波及効果が期待できる。

【根拠データ】
・生命理工学部構想: 文科省支援事業に選定、補助金約20億円確定（上期事業運営状況）
・設置予定: 令和10年度
・習志野新棟建設: 12.4億円（中期設備投資計画に計上）

【補足/対策】
生命理工学部は理学部の改組であり、学納金収入の大幅増は見込みにくい。ただし補助金20億円は法人財務にとって有意。大橋病院としては、新学部の研究者との共同研究（特に生命科学・バイオ分野）を通じて、先進的な医療技術の臨床応用や治験の受入拡大を模索する機会となりうる。